



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : سعاد عبدالرؤف عبدالرازق عويس

العنوان : الحمام

الحي / المدينة : ناصر

المحافظة : بني سويف

تاريخ تسجيل الإستمارة : 09-10-2026

رقم البطاقة : 26707092200447 رقم التليفون : 01118479568

العمر (تاريخ الميلاد) : 09-07-1967 المهنة : بدون عمل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سعاد عبدالرؤف عبدالرازق عيسى National ID: 26707092200447	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

ماد
ر.ب. الزلفاء ج. الزلفاء ج.
قرية الدمنيم
مركز فاصل - بني سويف



٢٦٧٠٧٠٩٢٢٠٠٤٤٧

KE6314996

DMS
مفاتيح دار الهم



٢٠٢٣/٠٩ ٢٦٧٠٧٠٩٢٢٠٠٤٤٧

ربة منزل

متزوجة

مسلمة

أنثى

جمال زكريا محمود البنا

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٣/٠٩/٢٣





Pathology Report

Name: سعاد عبد الرؤوف عبد الرازق

Age: 50 years.

Clinical data: Right breast mass.

Specimen type: Tru cut biopsy.

Date: 10/12/2019

Lab. Number: 1371

Hospital Number: مبادرة/2019

استلم

Gross Description:

Two partly fragmented greyish white tissue cores, the longest was; 1.6 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:

Histopathological examination of section prepared breast tissue core, infiltrated by invasive malignant growth, formed of cords and trabeculae of moderately anaplastic ductal epithelial cells, with desmoplastic stroma.

Diagnosis:

Invasive mammary carcinoma GII, of terminal duct unit, for IPT;
(ER, PR, Her2 & Ki67).

Prof. Dr. Lubna Omar

Prof. Dr. Essam Ayad

Name: سعاد عبد الروؤف عبد الرازق		
MR. : 1476		
Detailed Medical Report		
		السيد
تجبة طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient was diagnosed with triple-negative breast cancer (CT3, no metastatic disease, ER8/8, PR8/8, HER2-negative) and received neoadjuvant chemotherapy followed by radiation therapy and breast-conserving surgery in June 2020. Adjuvant tamoxifen was initiated and subsequently switched to letrozole (Femara) in November 2022 in conjunction with zoledronic acid (Zometa). The patient presented for a Femara refill and was noted to have dyspnea; a chest CT was ordered, which demonstrated right basal subpleural mass (R BSM) and pleural effusion (PAUS). The imaging results are pending. Follow-up imaging in July 2026 showed a normal mammogram, a calcified gallbladder with an atrophic kidney and a uterine fibroid on ultrasound, and a goiter with calcification on chest CT. The patient is scheduled for a neck ultrasound and a follow-up visit for Femara on 2 November 2026.		
تحريراً في ,		
	التاريخ :	20-09-2026
	الوقت :	
	الطبيب المعالج :	dina makram
يعتمد ,		



Patient Name: Souad Abdalrwaf Abdel Razek Owais	Date : 23/03/2023
Exam : C.T. ABDOMEN & PELVIS WITH CONTRAST	Age : 55 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 11893

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

I Chest:-

- Right upper lobe anterior segment sub-pleural reticulations likely post therapeutic sequel.
- Small right upper lobe fissural based nodule is seen measuring about 5 mm.
- No otherwise sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Relatively small sized left kidney is noted showing no stones or back-pressure changes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of the right kidney with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.



Patient Name: Souad Abdalrwaf Abdel Razek Owais	Date : 23/03/2023
Exam : C.T. ABDOMEN & PELVIS WITH CONTRAST	Age : 55 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 11893

- Bulky uterus with anterior wall fibroid is seen measuring about 5.5 cm.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic collections.
- No lytic or sclerotic lesions.

Opinion:

Known case of breast cancer showing:

- *Small right upper lobe fissural based nodule likely of benign nature.*
- *Bulky uterus with anterior wall fibroid*

Dr. Ahmed M. Rozeka, MSc

Signature Prof. Menna Tallah Hanafy
27/03/2023 03:37 م



وحدة زلازل الأورام

قسم التشخيص

القصر العيني

وحدة تشخيص امراض الثدي

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Patient Name: سعد عبد الرؤوف عبد الرازق

lab.No:2020-27/ (4TM)

Date: 1 /2020

Sex: Female

CLINICAL DATA: A case of breast cancer, for estrogen, progesterone receptors and Her-2/neu.

PROCEDURE:

Sections were prepared from paraffin blocks treated for (ER clone SP1), (PR clone 112), (Her 2 neu-clone 4B5) automatically stained in Bench mark ET (VENTANA) using UL TRA VIEW DAB Detection Kit, Hematoxylin as counter stain.

RESULTS:

Examination of sections treated for ER and PR receptors revealed intense nuclear staining in most of tumor cells by chromogen.

Examination of sections treated for Her-2/neu revealed no membranous staining of tumor cells by chromogen.

CONCLUSION:

Tumor Cells Were:

- ✓ Positive For ER & PR, Score 8/8.
- ✓ Negative For Her-2/neu, (Score 0).

Comment: All controls show appropriate reactivity. The H&E slide as well as paraffin block were re-enclosed back.

PROF. DR. AHMED ABD AL-AZIZ

PROF. DR. SAMIA GABAL

أ.د. أحمد عبد العزيز
أ.د. سامية جبال



Exam Information:

<u>Patient Name:</u> SOAD A	<u>Date of birth:</u> 09/07/1967
<u>Arabic Name:</u> سعاد عبد الزوروف	<u>Patient Gender:</u> F
<u>Patient RIS ID:</u> 323609	<u>Exam Date:</u> 30/03/2023
<u>Patient HIS ID:</u> 123006054	<u>Approved by:</u> Dr. Hoda Fathy
<u>Written by:</u> Dr. Hoda Fathy	

^{99m}Tc MDP Bone Scan Report (26-3-2023)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of ^{99m}Tc MDP
Revealed:

- No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- Both kidneys are visualized.

Conclusion:

- No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Dr.Omnia Talaat,MD

Much Obligated